

시험 관련 코멘트



소화불량/만성 복통의 경우 복통과 함께 나타나거나 단독 증상으로 흔히 발생할 수 있습니다. 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인을 감별하는 것이 중요하

며, 병력 청취와 신체 진찰에서 감별 진단을 시행할 수 있어야 합니다. 소화불량의 기질적 원인으로는 신생물, 소화성 궤양/역류 질환, 위, 간담체의 염증/허혈, 위장자 운동 이상 등을 고려해야 합니다.

병력 청취 시 증상이 **위와 관련된 경우 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력**을 물어보는 것이 좋습니다. 평소 식습관이 소화불량과 밀접한 관련이 있으므로 사회력에서 물어보아야 합니다. 악화/완화 요인에서 원인 질환에 따른 위험 요인 외에도 공복 시/식후 소화불량이 심해지는지를 물어본다면 진단 범위를 좁혀 갈 수 있습니다. 소화불량의 경우 **과거 소화기 병력을 확인**하는 것이 중요합니다. 그동안 건강 검진에서 상부 위장관내시경, 대장내시경을 받은 적이 있는지, 이상 소견은 없었는지 역시 확인해야 합니다. 원인 질환을 감별하기 어렵다면 기본으로 **기능성 소화불량 가능성을 염두**하는 것이 좋습니다.

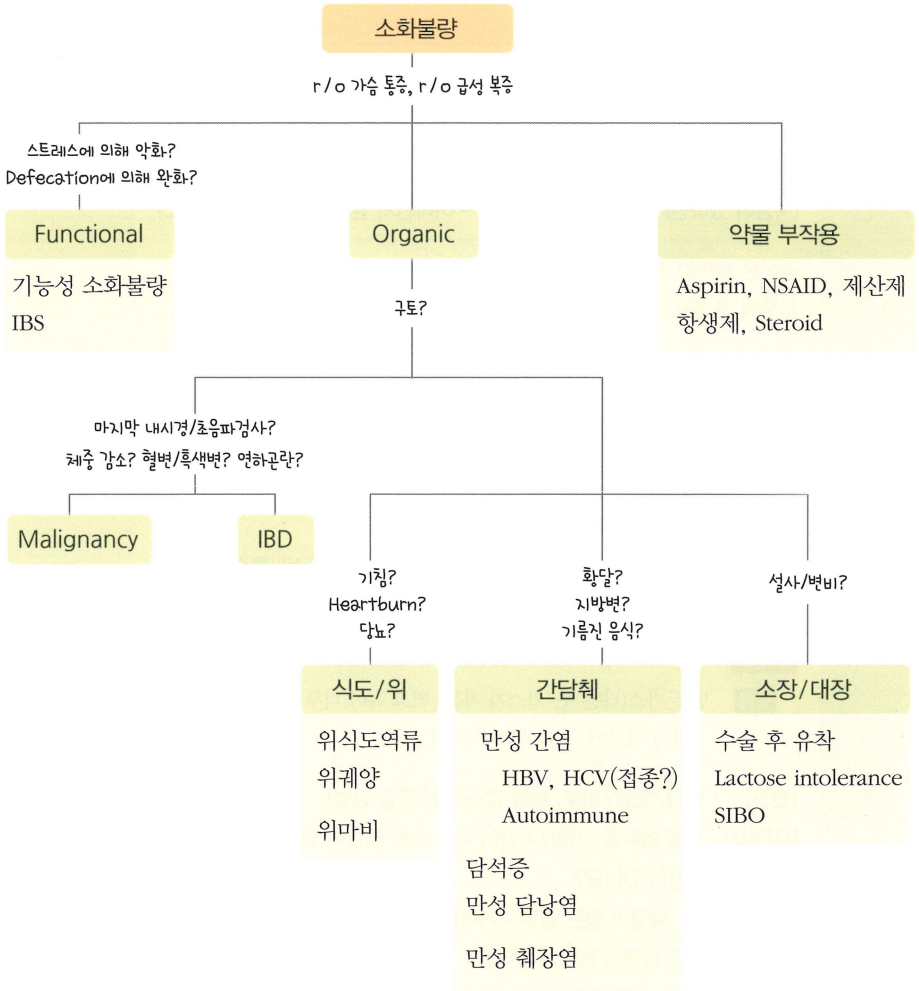
신체 진찰의 경우 소화불량 항목은 황달과 탈수를 확인하고, 림프절을 촉진하고, 복부 진찰(필요 시 Murphy's sign도) 진행해야 합니다.

환자 교육에서 **금주, 금연 뿐만 아니라** 카페인인 경우 위산 분비를 촉진하고 식도조임근을 이완시키기 때문에 **커피를 줄이는 것**에 대한 교육도 필요합니다.

## 질병별 진단 / 치료 계획 정리

| 계통     | 원인      | 질병                   | 진단 키워드                                                                              | 검사/치료                                                                              |
|--------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 위 / 소장 | 미란 / 궤양 | 위식도역류병 (GERD)        | <b>[병력]</b> 명치 부위에 타는 듯한 통증, 식후/누울 때 악화, 제산제 복용 시 완화<br><b>[검진]</b> 특이 소견 없음        | <b>[검사]</b> 위내시경, 24시간 식도 pH검사<br><b>[치료]</b> 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정              |
|        |         | 위염★ / 위궤양★ / 십이지장궤양★ | <b>[병력]</b> 속쓰림, 식후에 악화(위궤양), 공복 시 악화(십이지장궤양), 명치부 통증<br><b>[검진]</b> 상복부 압통 있을 수 있음 | <b>[검사]</b> 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사<br><b>[치료]</b> 양성자펌프억제제, 제산제, H. pylori 제균 치료 |

|        |    |                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                                   |
|--------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위 / 소장 | 종양 | 위암★<br>(gastric cancer)                                         | <b>[병력]</b> 체중 감소, 소화불량, 흑색변, 이전 위내시경에서 궤양 소견<br><b>[검진]</b> 특이 소견 없음                                        | <b>[검사]</b> 위내시경, 복부 CT<br><b>[치료]</b> 위절제술, 내시경점막절제술, 항암 치료                                                      |
|        | 마비 | 당뇨병 위마비<br>(diabetic gastroparesis)                             | <b>[병력]</b> 오래된 당뇨 병력/<br>복부 팽만감/음식 구토/<br>상복부 불편감/식후 속쓰림<br><b>[검진]</b> 특이 소견 없음                            | <b>[검사]</b> 혈중 포도당, 당화혈색소, 위배출검사<br><b>[치료]</b> 당뇨 조절,<br>Metoclopramide, Cisapride                               |
| 간 담 체계 | 담  | 담석증★<br>(cholelithiasis)<br>만성 담낭염★<br>(chronic chole cystitis) | <b>[병력]</b> 담석 진단, RUQ 통증, 오심, 구토<br><b>[검진]</b> RUQ 압통 있을 수                                                 | <b>[검사]</b> 상복부초음파, LFT<br><b>[치료]</b> 쓸개절제술                                                                      |
|        | 췌  | 만성 췌장염<br>(chronic pancreatitis)                                | <b>[병력]</b> 심와부 통증, 제산제 복용 후에도 완화 안 됨,<br>음주 후 악화, 지방변<br><b>[검진]</b> 심와부 통증, 등으로 뻐치는 통증                     | <b>[검사]</b> 복부초음파, 복부 CT, 복부 MRI, 내시경역행담췌관조영<br><b>[치료]</b> 췌장효소 보충, 금주/금연, 식이 조절(과식, 고지방식 자제), 통증 조절             |
|        | 간  | 만성 간염<br>(chronic hepatitis)                                    | <b>[병력]</b> 피로, 식욕 저하, 구역, 구토, 근육통, 소변색 진해진, 황달<br><b>[검진]</b> 간비대될 수 있으나 확인은 어렵다.                           | <b>[검사]</b> HBsAg, anti-HAV, anti-HCV, LFT<br><b>[치료]</b> 항바이러스제, 보존적 치료                                          |
| 기타     |    | 젖당불내성★<br>(lactose intolerance)                                 | <b>[병력]</b> 우유 마시면 속이 불편함, 묽은변<br><b>[검진]</b> 이상 소견 없음                                                       | <b>[검사]</b> 수소날숨검사,<br>젖당부하검사<br><b>[치료]</b> 유당회피요법                                                               |
|        |    | 과민대장증후군★<br>(IBS)                                               | <b>[병력]</b> 젊은 여성/만성적 복통/<br>배변 후 완화/배변 습관 및 양상 변화/복부 팽만/잦은 트림 및 방귀/소화불량/<br>스트레스 시 악화<br><b>[검진]</b> 경미한 복통 | <b>[검사]</b> 대변검사, 대장내시경, CBC<br><b>[치료]</b> 심리적 안정,<br>적당한 운동과 휴식,<br>식습관 교정(고섬유, low FODMAP, 술/커피 줄이기), 진경제, 완하제 |
|        |    | 기능 소화불량★<br>(functional dyspepsia)                              | <b>[병력]</b> 상복부 통증/쓰림, 식후 충만감, 조기 포만감, 불규칙한 식습관 및 생활 습관/<br>스트레스/내시경 정상<br><b>[검진]</b> 대체로 정상, 상복부 압통        | <b>[검사]</b> 원칙적으로 필요 없으나 위내시경, 신속요소분해효소검사 등으로 다른 질환 감별<br><b>[치료]</b> 양성자펌프억제제(궤양형), 운동 촉진 약물(운동장애형)              |



STEP 1 병력 청취

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O  | 언제부터 속이 쓰렸나요? → 소화가 안됐나요?<br>갑자기 그러신 건가요?/아니면 서서히 속쓰림이 나타났나요?<br>하루 중 언제 주로 그런 것 같으세요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| L  | (복통이 있다면) 위치는 어디인가요? → 어디인지 짚어주실 수 있으신가요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| D  | 증상은 얼마나 지속되나요?<br>하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Co | 점점 심해지나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ex | 이전에도 비슷한 증상이 있으셨나요?<br>당시 치료는 받으셨나요?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C  | <p><b>[양상]</b> 속이 어떻게 불편하신가요?<br/>(타는 듯/속이 더부룩/가스 차는 느낌/소화가 안 됨/통증)</p> <p><b>[정도]</b> 증상이 얼마나 심하신가요? (일상 생활에 지장을 받으시나요?/NRS)</p> <p><b>암기법</b> 탄 돈가스 먹고 속이 더부룩해져서 일지에 쓰기로 하였다.</p> <p><b>설명</b> 탄 돈가스(타는 듯, 가스가 차는) 먹고 속이 더부룩해져서(속이 더부룩한) 일지(일상 생활에 지장이 있는)에 쓰기로 하였다.</p>                                                                                                                                           |
| A  | <p><b>[전신]</b> 발열/오한/피로/체중 감소(악성 종양 감별)</p> <p><b>[GERD]</b> 신물 올라옴/기침/가슴이 타는 듯한 통증이 있나요?</p> <p><b>[간담체]</b> 황달이 있나요?<br/>+ 황달이 있는 경우 : 가려움, 복수, 소변색/대변색 변화</p> <p><b>[IBS]</b> 배변 습관의 변화가 있나요?</p> <p><b>[소화기]</b> 식욕 저하/구역/구토/설사/변비/혈변/흑색변/복통/속쓰림/복부 팽만/삼킬 때 어려움(연하곤란)이 있나요?</p> <p><b>암기법</b> 연신 물배만 채우는 습관은 곤란하다.</p> <p><b>설명</b> 연신 물(신물이 올라옴)배만 채우는 습관(배변 습관의 변화)은 곤란하다(연하곤란).</p> <p><b>[정신]</b> 우울, 불안</p> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F   | [악화/완화 인자] open question                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | [위염/위궤양] 식사하기 전과 후 중에 더 속쓰림이 심해지는 상황이 있나요?                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | [젓당불내성] 우유나 기름진 음식을 먹으면 더 속이 쓰린가요?                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | [IBS] 대변을 보고 나면 속쓰림이 완화되나요?                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | [스트레스] 최근에 스트레스를 받는 일이 있었나요?                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>암기법</b> 제우스(우유, 스트레스)는 음식 대기 중                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <b>설명</b> 제우스(우유, 스트레스)는 음식(식사) 대기(대변 본 후, 기름진 음식) 중                                                                                                                                                                                                                                  |
| E   | 이전에 건강 검진 받은 적 있으세요?/위내시경, 대장내시경 받으셨나요?/결과는 어땠나요?<br>간염 예방접종은 다 맞으셨나요?<br>☞ 위/대장내시경 시행 여부와 결과도 반드시 문도록 합니다.                                                                                                                                                                           |
| 외   | 수술을 받으신 적 있나요?/배를 다치신 적 있나요?                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 과   | 고혈압/당뇨/고지혈증/간질환 있으신가요?<br>위염이나 위궤양을 진단 받은 적 있으신가요?                                                                                                                                                                                                                                    |
| 약   | 복용 중인 약물이 있나요? (아스피린, NSAID, 제산제, 항생제, 스테로이드)<br>☞ 시간이 없을 경우 진통제(NSAID)와 항생제 복용 여부를 묻습니다.                                                                                                                                                                                             |
| 사   | 직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요?<br>음주는 하세요?/흡연은 하시나요?/커피는 하루에 몇 잔 정도 드시나요?<br>[식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/맵거나 자극적인 음식을 좋아하시나요?<br>[운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?                                                                                                                    |
| 가   | 가족 중에 위암이나 위궤양 등을 진단받은 분이 있으신가요?                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 여   | 실례지만 마지막 월경 시작일이 언제인가요?/월경 주기?/월경통/월경량 심한 편?<br>임신 가능성이 있나요?                                                                                                                                                                                                                          |
| P/E | 이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요?<br>오늘 측정한 혈력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!).<br>[앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달)<br>2. 입인두 : 위산 역류<br>3. 목★ : 림프절 촉진(supraclavicular lymph node까지 촉진)<br>4. CVAT : (복통 호소 시 시행을 고려합니다.) 뒤로 돌아주세요.<br>반드시 양쪽 다 확인, 양쪽을 한번씩만 치는 것이 아니라 연속적으로 위에서 내려가며 여러 번 쳐준다. |

[누워서] 5. 복부★

신진 수술 흔적, 팽만/청진 5구역, 3초간/타진 4군데 이상/촉진 알, 깊 촉진

⊕ 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진 및 촉진

[특이검사★] Murphy's sign

6. DRE : 직장수지검사

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

## STEP 2 환자 교육

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 공감    | 소화불량 or 속쓰림 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.                                                                                                                                                                                                                    |
| 추정 진단 | 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 위궤양이 가장 의심됩니다.<br>[병력 상 당뇨가 오래 조절되지 않은 경우] 당뇨병 위마비 등으로 당뇨가 소화불량 원인일 수 있습니다. 이 경우 혈당을 엄격하게 조절하는 것이 중요합니다.                                                                                                             |
| 감별 진단 | 그러나 최근 체중이 감소하고 식욕 변화도 있으면서 평소 음주와 흡연력도 있으셔서 위암의 가능성을 배제할 수는 없습니다.                                                                                                                                                                                 |
| 검사    | 이런 경우 위내시경검사로 위에 어떤 기질적 문제가 있는지 확인하는 것이 필요합니다.<br>검사를 진행해도 괜찮을까요?<br>검사를 위해 지금부터 금식을 하셔야 합니다.                                                                                                                                                      |
| 치료    | 만약 위궤양으로 진단되면 위산 분비를 억제하는 약을 드리고 제균 치료를 시행해 볼 수 있습니다. 만일 위암으로 진단되면 수술이나 항암 치료 등이 필요할 수 있습니다.<br>가능성 소화불량으로 진단 시 생활 습관을 개선하고 소화불량을 일으키는 약물을 중단하고, 추가로 위산억제제나 위장운동촉진제 약물 치료를 병행할 수 있습니다.                                                             |
| 예후    | 하지만 아직 검사를 진행한 것이 아니기 때문에 너무 걱정하지는 마세요.<br>이렇게 증상이 빨리 나타났을 때 병원에 오신 것은 정말 잘하신 것입니다.                                                                                                                                                                |
| 교육    | [응급] 지금은 증상이 심하지 않지만 집에 가서서 음식을 삼키기 힘들거나, 어지럽고, 피를 토하거나 변에 피가 묻어나오거나 검은 변을 보면 즉시 병원을 방문해 주세요.<br>[식습관] 생활 속에서 맵거나 자극적인 음식을 피해주시고,<br>[생활 습관] 적절히 운동을 해주면서 스트레스를 덜 받게 하는 것 또한 중요합니다. 금연과 금주가 중요하며, 카페인의 경우 위산 분비를 촉진시키니 섭취를 줄여준다면 증상 완화에 더 도움이 됩니다. |
| 질문    | 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?                                                                                                                                                                                                                             |

## ❖ 기본적 진단 계획★

- ① 복부 X-ray, 복부 CT
- ② 위식도내시경
  - 45세 이상
  - 악성 경고 증상 +
  - 만성 증상에 변화 +
  - 환자가 악성 종양에 대해 걱정할 때
- ③ 궤양 : 요소나소검사, 신속요소분해효소검사(위내시경 시 같이 시행)
- ④ GERD : 24시간 식도 pH검사

## ❖ 치료 계획

|     |            |                                       |
|-----|------------|---------------------------------------|
| 위장관 | 위식도역류      | 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정               |
|     | 위궤양        | 양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제 |
|     | 십이지장궤양     | 양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제 |
|     | 위암         | 위절제술, 내시경적 점막하절제술, 항암 치료              |
| 간담체 | 담석증/만성 담낭염 | 금식 유지, 항생제, 수액                        |
|     | 만성 췌장염     | 금식 유지, 췌장효소 보충, 혈당 조절                 |
|     | 간염         | 항바이러스제, 보존적 치료                        |
| 기타  | 기능성 소화불량   | 심리적 안정, 적절한 운동과 휴식                    |
|     | 과민대장증후군    | 심리적 안정                                |
|     | 당뇨성 마비     | 당뇨 조절                                 |
|     | 젖당불내성      | 유당 회피                                 |

## ❖ 환자 안내 / 생활 습관 교육

- ① 생활 습관 개선의 중요성 : 술/담배 제한, 적절한 유산소 운동, 체중 조절, 식습관 개선(규칙적 식습관, 지방이 적고 섬유소가 많은 음식), 스트레스 관리, 카페인 제한

- ② 당뇨병이 조절되지 않고 있는 경우 당뇨가 소화불량의 원인일 수 있음을 설명하고 엄격한 조절 강조
- ③ 기질적 문제가 의심되는 경우 복부 CT 등 추가적인 검사가 필요할 수 있음을 강조



**keyword**

소화불량/만성 복통의 경우 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인으로 나누어  
감별하기

소화불량의 위치를 확인해 기질적 원인인 경우 감별하기

기질적 원인의 위험 요인 파악 : 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력, 스트레스, 음주/흡연

교육 : 생활 습관 개선(식습관+운동), 스트레스 조절, 금주/금연/카페인 섭취도 줄일 것을 교육하기

응급 상황 교육 : 연하곤란, 어지럼, 토혈, 혈변/흑색변 시 내원 교육



## Memo



11ème